

CHU BESANÇON PMF	Prise en charge des Lésions Obstétricales du Sphincter de l'Anus :LOSA		090 OBS 210 PTxx002 Version 4 Décembre 2024 Page 1 / 7
	PROTOCOLE		

1 – Concerne :

Les médecins, les internes, les sages-femmes des services d'obstétrique et de salle de naissance.

2 – Rappels : Classification des déchirures périnéales. (OMS)

Premier degré : déchirure touchant l'épithélium cutané, vaginal et/ou vulvaire.

Deuxième degré : déchirure périnéale impliquant les muscles périnéaux mais pas le muscle sphincter de l'anus.

Troisième degré : déchirure impliquant le complexe du sphincter anal :

3a : touchant moins de 50% de l'épaisseur du sphincter anal externe

3b : touchant plus de 50% de l'épaisseur du sphincter anal externe

3c : touchant le sphincter anal interne

Quatrième degré : déchirure impliquant le complexe du sphincter anal (externe et interne) et la muqueuse rectale ou déchirure « en boutonnière » impliquant uniquement la muqueuse rectale.

Intitulé et référence du document associé : néant			
REDACTION 03/12/2024 Prénom – Nom (s) : Pr RAMANAH Dr R BASSI Signature (s) :	VERIFICATION 11/12/24 Prénom – Nom : Signature :	VALIDATION 11/12/2024 Prénom – Nom (s) : Signature (s) :	APPROBATION 11/12/2024 Prénom – Nom : Signature :
Liste de diffusion : PMF Relecture périodique du document - sans modification par : le :			

	Prise en charge des Lésions Obstétricales du Sphincter de l'Anus : LOSA		090 OBS 210 PTxx002 Version 4 Décembre 2024 Page 2 / 7
	PROTOCOLE		

3 – Application :

A. Suture :

- **Evaluation de la déchirure**
 - **Examen attentif pour déterminer le stade de la déchirure**
 - Réalisation d'un **toucher rectal** pour faire rouler le sphincter entre le pouce et l'index et évaluer son épaisseur
 - ➔ Présence d'un **sénior obligatoire**
- **Mise en condition pour la réparation périnéale** :
 - A. Position gynécologique en salle d'accouchement (ou au bloc opératoire si nécessaire)
 - B. Faire appel à un assistant
 - C. Vérification d'une analgésie appropriée, sollicitation de l'anesthésiste
 - D. Asepsie, badigeonnage, mise en place de champs stériles, éclairage adéquat
 - E. Antibioprophylaxie systématique : une injection IVL de Céfazoline 2g associée à une injection IVL de Métronidazole 1g (selon les recommandations de la société française de colo-proctologie)
En cas d'allergie aux bêta-lactamines, il est possible de remplacer la Céfazoline par une injection IVL de Clindamycine 900 mg.
 - F. Utilisation du **KIT suture LOSA** (pinces d'Allis, porte aiguille, pince hémostatique)
- **Réparation périnéale par un senior**
 - A. Repérage et mise sur pince d'Allis des 2 chefs du sphincter externe de l'anus
 - B. Suture de la muqueuse anale par des points séparés au fil synthétique résorbable tressé Vicryl® 3/0
 - C. Suture du sphincter anal interne par des points simples au fil synthétique monofilament résorbable PDS® 3/0 (ou à défaut au fil tressé Vicryl® 2/0)
 - D. Suture « bout à bout » ou « en paletot » du sphincter externe de l'anus par des points séparés au fil synthétique monofilament résorbable PDS® 3/0 (ou à défaut au fil tressé Vicryl® 2/0)
Les fils doivent être coupés courts et recouverts par les muscles périnéaux pour minimiser tout inconfort causé par ceux-ci.
Du fil monofilament est à privilégier car ils sont sources de moins de colonisation bactérienne et d'infection.
 - E. Suture du plan musculaire par des points séparés avec un fil synthétique résorbable rapide tressé type Glycofil® 0
 - F. Suture du plan vaginal par des points séparés ou par un surjet avec un fil synthétique résorbable rapide tressé type Glycofil® 0
 - G. Suture cutanée par des points séparés avec un fil synthétique résorbable rapide tressé type Glycofil® 3/0
- **Toucher rectal systématique** en fin d'intervention
 - Pour s'assurer de la nouvelle intégrité du sphincter anal
 - Evaluer l'absence de points transfixiants au niveau de la muqueuse rectale
- **Injection intra-thécale ou péridurale de Morphine** à visée antalgique par l'anesthésiste de garde

 PMF	Prise en charge des Lésions Obstétricales du Sphincter de l'Anus :LOSA		090 OBS 210 PTxx002 Version 4 Décembre 2024 Page 3 / 7
	PROTOCOLE		

- **Compte rendu opératoire précis** sur le type de déchirure, et la description de la réparation
- **Explications données à la patiente** sur le type de déchirure périnéale, et les recommandations en post-partum et le suivi post natal

B. En post- partum immédiat, en suites de Naissances :

- **Antibiothérapie** : Elle n'a pas sa place dans la prise en charge des LOSA de type III en cas d'antibioprophylaxie bien conduite lors de la réparation sphinctérienne en salle d'accouchements.
Par ailleurs, en cas de LOSA de type IV, il sera proposé une antibiothérapie par :
⇒ AUGMENTIN 1g x3 par jour par voie orale pendant 7 jours
⇒ En cas d'allergie : METRONIDAZOLE 500 mg*3 par jour pendant 7 jours
- **Régime sans résidus** : jusqu'à la première selle puis régime normal
Cf document du CHRU –service diététique : **Régime sans résidus ANNEXE 1**
- **Lactulose pendant 10 jours après l'accouchement : FORLAX 1 sachet par jour**
- **Antalgiques adaptés à la douleur, en débutant par des antalgiques de palier 1 : paracétamol 1 g 4 fois par jour + AINS (PROFENID) si besoin.**
- **Surveillance de la reprise mictionnelle en post-partum**
- **Bains de siège non recommandés**
- **Durée d'hospitalisation à évaluer selon les patientes (de 3 à 6 jours)**
- **A J0 : Programmation du rendez-vous pour la consultation post-natale : SF suites de naissance => secrétariat Gynéco : tel 18 488**

C. A la sortie, pour le retour à domicile :

- **Si celui-ci a été prescrit, maintien du traitement antibiotique pour une durée totale de 7 jours uniquement en cas de LOSA de type IV**
- **Maintien du traitement laxatif pendant un mois (selon les patientes)**
→ FORLAX® : 1 à 3 sachets par jour
- **Antalgiques**
- **Régime normal, en évitant la constipation**

	Prise en charge des Lésions Obstétricales du Sphincter de l'Anus :LOSA		090 OBS 210 PTxx002 Version 4 Décembre 2024 Page 4 / 7
	PROTOCOLE		

Cf document CHRU –Service diététique : [Alimentation riche en fibres ANNEXE 2](#)

- **Remettre le questionnaire d'évaluation des symptômes et de la qualité de vie en lien avec les troubles de statique pelvienne et périnéaux à la patiente :**

A remplir pour la consultation post natale à 8 semaines

Cf : [Fiche évaluation des symptômes et de la qualité de vie en lien avec les troubles de la statique pelvienne et périnéaux \(ANNEXE 3\)](#)

- **Visite de sortie à faire par Interne de DES de Gynécologie Obstétrique**
- **Suivi post natal au CHRU** : à 6 ou 8 semaines du post-partum avec senior (Celui ayant suivi l'accouchement, intervenu à l'accouchement, Chef de clinique)
- **Envisager le début de la rééducation périnéale qu'après une cicatrisation complète. (Pas avant 8 semaines post-partum).**
Il n'y a pas d'indication à prescrire une rééducation anorectale à ce stade.

D. Visite post natale à 6 - 8 semaines du post-partum

- **Interrogatoire :**
 - **Reprise des évènements**, expliquer ce qu'est une déchirure du sphincter
 - Evaluer la **cicatrisation** et ses **complications** : douleurs, incontinence anale ou urinaire, dyspareunies.
 - Evaluation la **reprise des rapports sexuels** et une éventuelle **constipation** à traiter
 - Evaluer les **symptômes** à l'aide de la **fiche de scores** remise à la patiente à la maternité
- **Examen clinique :**
 - Evaluer la **cicatrisation périnéale** : désunion ? signe d'infection ? fistule ?
 - **Aspect de la région péri-anale** : disparition des plis radiés anaux ?
 - Evaluation des **muscles élévateurs de l'anus** : défaut anatomique ? force ?
(Cotation de 0 à 5)
 - **Toucher rectal** : sphincter perçu ? tonus ? épaisseur ?
 - Récupérer la fiche questionnaire et le déposer au secrétariat des consultations pour qu'elle soit scannée dans le dossier de la patiente
 - Aucune échographie périnéale systématique n'est à prescrire en l'absence de symptôme

CHU BESANÇON PMF	Prise en charge des Lésions Obstétricales du Sphincter de l'Anus :LOSA		090 OBS 210 PTxx002 Version 4 Décembre 2024 Page 5 / 7
	PROTOCOLE		

E. En cas de femmes asymptomatique, lors de la visite post natale :

- **Rassurer** la patiente sur le risque d'incontinence anale
- Pas de suivi proctologique nécessaire, pas de précaution particulière
- Rééducation périnéale possible et encouragée par la sage-femme ou une masso-kinésithérapeute (LOSA : marqueur du traumatisme du plancher pelvien)
- Informer la patiente en cas de prochaine grossesse :
 - Risque de nouvelle LOSA entre 5 à 8 % (proche de celui de la nullipare)
 - Pas de césarienne systématique si pas de symptôme et examen normal

F. En cas de symptômes et défaut clinique franc lors de la visite post-natale :

Un défaut clinique franc se définit par une absence de sphincter perçu ou une absence d'épaisseur périnéale.

- Probable échec de réparation
- Programmer une **échographie périnéale trans-labiale** auprès des Drs Magnin ou Tholozan
- Orientation rapide auprès d'un **gynécologue obstétricien du CHU** qui orientera la patiente selon la sévérité des symptômes, l'examen clinique et la prise en charge déjà réalisée vers un gastro-entérologue, médecin de la douleur, kinésithérapeute spécialisé en pelvi-périnéologie, échographiste, radiologue et/ou un chirurgien digestif
- Le cas de la patiente sera à présenter en **réunion de concertation pluridisciplinaire de pelvi-périnéologie** par le gynécologue-obstétricien qui prend en charge la patiente.

ANNEXES

Annexe 1 : Régime pauvre en résidus

Annexe 2 : Alimentation riche en fibres

Annexe 3 : Fiche de suivi après déchirure périnéale sévère

4 – Références :

[1–23]

- [1] Bek KM, Laurberg S. Risks of anal incontinence from subsequent vaginal delivery after a complete obstetric anal sphincter tear. Br J Obstet Gynaecol 1992;99:724–6. <https://doi.org/10.1111/j.1471-0528.1992.tb13870.x>.

 PMF	Prise en charge des Lésions Obstétricales du Sphincter de l'Anus :LOSA		090 OBS 210 PTxx002 Version 4 Décembre 2024 Page 6 / 7
	PROTOCOLE		

- [2] Walsh CJ, Mooney EF, Upton GJ, Motson RW. Incidence of third-degree perineal tears in labour and outcome after primary repair. *Br J Surg* 1996;83:218–21.
- [3] Fynes M, Donnelly VS, O'Connell PR, O'Herlihy C. Cesarean delivery and anal sphincter injury. *Obstet Gynecol* 1998;92:496–500. [https://doi.org/10.1016/s0029-7844\(98\)00256-7](https://doi.org/10.1016/s0029-7844(98)00256-7).
- [4] Poen AC, Felt-Bersma RJ, Strijers RL, Dekker GA, Cuesta MA, Meuwissen SG. Third-degree obstetric perineal tear: long-term clinical and functional results after primary repair. *Br J Surg* 1998;85:1433–8. <https://doi.org/10.1046/j.1365-2168.1998.00858.x>.
- [5] Sultan AH, Monga AK, Kumar D, Stanton SL. Primary repair of obstetric anal sphincter rupture using the overlap technique. *Br J Obstet Gynaecol* 1999;106:318–23. <https://doi.org/10.1111/j.1471-0528.1999.tb08268.x>.
- [6] Fernando RJ, Sultan AH, Radley S, Jones PW, Johanson RB. Management of obstetric anal sphincter injury: a systematic review & national practice survey. *BMC Health Serv Res* 2002;2:9. <https://doi.org/10.1186/1472-6963-2-9>.
- [7] Tjandra JJ, Han WR, Goh J, Carey M, Dwyer P. Direct repair vs. overlapping sphincter repair: a randomized, controlled trial. *Dis Colon Rectum* 2003;46:937–42; discussion 942–943. <https://doi.org/10.1007/s10350-004-6689-8>.
- [8] Mahony R, Behan M, O'Herlihy C, O'Connell PR. Randomized, clinical trial of bowel confinement vs. laxative use after primary repair of a third-degree obstetric anal sphincter tear. *Dis Colon Rectum* 2004;47:12–7. <https://doi.org/10.1007/s10350-003-0009-6>.
- [9] Buppasiri P, Lumbiganon P, Thinkhamrop J, Thinkhamrop B. Antibiotic prophylaxis for fourth-degree perineal tear during vaginal birth. *Cochrane Database Syst Rev* 2005;CD005125. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD005125.pub2>.
- [10] Garcia V, Rogers RG, Kim SS, Hall RJ, Kammerer-Doak DN. Primary repair of obstetric anal sphincter laceration: a randomized trial of two surgical techniques. *Am J Obstet Gynecol* 2005;192:1697–701. <https://doi.org/10.1016/j.ajog.2004.11.045>.
- [11] Fernando R, Sultan AH, Kettle C, Thakar R, Radley S. Methods of repair for obstetric anal sphincter injury. *Cochrane Database Syst Rev* 2006;CD002866. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD002866.pub2>.
- [12] Fernando RJ, Sultan AH, Kettle C, Radley S, Jones P, O'Brien PMS. Repair techniques for obstetric anal sphincter injuries: a randomized controlled trial. *Obstet Gynecol* 2006;107:1261–8. <https://doi.org/10.1097/01.AOG.0000218693.24144.bd>.
- [13] Williams A, Adams EJ, Tincello DG, Alfievic Z, Walkinshaw SA, Richmond DH. How to repair an anal sphincter injury after vaginal delivery: results of a randomised controlled

 CHU BESANÇON PMF	Prise en charge des Lésions Obstétricales du Sphincter de l'Anus :LOSA		090 OBS 210 PTxx002 Version 4 Décembre 2024 Page 7 / 7
	PROTOCOLE		

trial. BJOG Int J Obstet Gynaecol 2006;113:201–7. <https://doi.org/10.1111/j.1471-0528.2006.00806.x>.

- [14] Sultan AH, Thakar R. Third and Fourth Degree Tears. In: Sultan AH, Thakar R, Fenner DE, editors. Perineal Anal Sphincter Trauma Diagn. Clin. Manag., London: Springer; 2007, p. 33–51. https://doi.org/10.1007/978-1-84628-503-5_4.
- [15] Buppasiri P, Lumbiganon P, Thinkhamrop J, Thinkhamrop B. Antibiotic prophylaxis for third- and fourth-degree perineal tear during vaginal birth. Cochrane Database Syst Rev 2014;CD005125. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD005125.pub4>.
- [16] Harvey M-A, Pierce M, Walter J-E, Chou Q, Diamond P, Epp A, et al. Obstetrical Anal Sphincter Injuries (OASIS): Prevention, Recognition, and Repair. J Obstet Gynaecol Can 2015;37:1131–48. [https://doi.org/10.1016/S1701-2163\(16\)30081-0](https://doi.org/10.1016/S1701-2163(16)30081-0).
- [17] Elliot V, Yaskina M, Schulz J. Obstetrical Anal Sphincter Injuries and the Need for Adequate Care. Female Pelvic Med Reconstr Surg 2019;25:109–12. <https://doi.org/10.1097/SPV.0000000000000684>.
- [18] Hickman LC, Propst K. Accurate diagnosis and repair of obstetric anal sphincter injuries: why and how. Am J Obstet Gynecol 2020;222:580.e1-580.e5. <https://doi.org/10.1016/j.ajog.2020.02.044>.
- [19] Viannay P, de la Codre F, Brochard C, Thubert T, Meurette G, Legendre G, et al. Prise en charge et conséquences des lésions obstétricales du sphincter anal (LOSA) : mise au point. J Chir Viscérale 2021;158:251–62. <https://doi.org/10.1016/j.jchirv.2020.07.128>.
- [20] Sultan AH, kamm M, Hudson C. Obstetric perineal trauma : an audit of training. Journal of Obstetrics and Gynaecology 1995, 15:19-23 n.d.
- [21] Thubert T, Cardaillac C, Fritel X, Winer N, Dochez V. [Definition, epidemiology and risk factors of obstetric anal sphincter injuries: CNGOF Perineal Prevention and Protection in Obstetrics Guidelines]. Gynecol Obstet Fertil Senol 2018;46:913–21. <https://doi.org/10.1016/j.gofs.2018.10.028>.
- [22] Société Nationale Française de Colo-Protocologie. Réparation en urgence d'une déchirure obstétricale. <https://www.snfcop.org/fiches-pratiques/fiches-techniques/divers-fiches-techniques/reparation-en-urgence-dune-dechirure-obstetricale/>
- [23] Venara A, Brochard C, Fritel X, Bridoux V, Abramowitz L, Legendre G, Siproudhis L. Management of obstetrical injuries to the anal sphincter : A survey of French current practice and perceptions according to the specialties. Journal de Chirurgie Viscérale 2021, Volume 158, Issue 5, 415 :1878-786X.